

# 헬리코박터 제균 치료 안내

진단부터 약물 복용·재검사까지, 제균 성공의 핵심을 한눈에

# 한국 성인 약 30%가 헬리코박터에 감염돼 있습니다

생활환경이 좋아지며 줄었지만, 여전히 위암의 주요 원인입니다

## 30%

한국 성인 감염률

1998년 약 67%에서 줄었지만 여전히 높습니다

## 6배

위암 위험

감염되면 위암 위험이 약 6배 높아집니다

## 35%↓

제균 뒤 위암 감소

여러 연구를 모은 분석에서 약 35% 감소



## 1군 발암물질입니다

세계보건기구 산하 국제암연구소(IARC)는 헬리코박터를 가장 확실한 발암 요인인 1군으로 분류하고 있습니다.



## 궤양·림프종의 원인

위·십이지장 궤양과 위 말트(MALT) 림프종의 주요 원인이기도 합니다. 제균 치료는 위암 발생을 의미 있게 낮춥니다.

Tip · 제균 치료는 '지금 아픈 곳'만이 아니라 앞으로의 위암 위험까지 낮추는 치료입니다.

근거 · 대한헬리코박터·상부위장관연구학회 진료지침 2022 · 국제암연구소(IARC)

# 위산 속에서 살아남는 나선형 세균입니다

한 번 감염되면 저절로 없어지지 않고, 오랜 염증이 단계적으로 위 점막을 바꿉니다

**1**

## 만성 위염

감염 뒤 평생

균이 스스로를 보호하는 효소  
(요소분해효소)로 위산을 견디며 위  
점막에 자리잡고 염증을  
일으킵니다.

**2**

## 위축성 위염

수십 년

염증이 오래가면 위 점막이  
얇아집니다.

**3**

## 장상피화생

전암성 변화

위 점막이 장 점막처럼 바뀝니다.  
위암 위험이 높아지는 단계입니다.

**4**

## 위암

일부에서

모든 감염자가 위암이 되지는  
않지만, 헬리코박터가 이 흐름의  
출발점입니다.

**언제·어떻게 옮나요** 대부분 어린 시절에 감염되며, 가족끼리 식기를 함께 쓰거나 입을 통해 옮는 경우가 흔합니다.

Tip · 이 흐름을 일찍 끊는 것이 제균 치료의 목적입니다.

근거 · 대한헬리코박터·상부위장관연구학회 진료지침 2022 · 코레아 위암 발생 단계

## 어떻게 진단하나요

내시경으로 조직을 떼어 보는 검사와, 내시경 없이 하는 검사로 나뉩니다

| 검사               | 방법과 특징                                      |
|------------------|---------------------------------------------|
| 신속요소분해효소 검사(CLO) | 내시경 때 떼어 낸 조직으로 바로 검사 · 30분~24시간 안에 결과      |
| 조직검사             | 현미경으로 확인 · 위축·장상피화생도 함께 평가                  |
| 세균 배양            | 항생제가 듣는지 확인 · 두 번 실패한 뒤 약을 고를 때             |
| 요소호기검사           | 약을 마신 뒤 내쉬는 숨으로 검사 · 정확도 95% 이상, 재검사에 주로 사용 |
| 대변 항원검사          | 대변으로 검사 · 어린이·고령자도 부담이 적음                   |
| 혈액 항체검사          | 과거 감염도 양성 · 치료 후 확인에는 쓰지 않음                 |



설명용 그림 · 위 점막에 붙은 헬리코박터(초록 나선형 세균)와 숨으로 하는 요소호기검사 기계, 대변 검사 통입니다.

Tip · 치료 뒤 재균 확인은 요소호기검사나 대변 항원검사로 합니다.

근거 · 대한헬리코박터·상부위장관연구학회 진료지침 2022

## 누가 제균 치료를 받나요

위쪽 세 가지는 꼭 권하고, 아래쪽은 상황에 따라 권합니다

### 꼭 권함 · 소화성 궤양

위궤양·십이지장궤양은 지금 있든 나은 뒤든 모두 대상입니다. 재발을 크게 줄입니다.

### 꼭 권함 · 위 말트 림프종

초기에는 제균만으로도 좋아질 수 있는 유일한 림프종입니다.

### 꼭 권함 · 조기 위암 절제 뒤

내시경으로 떼어 낸 뒤 새 위암이 생길 위험을 약 50% 줄입니다.

### 권함 · 위암 가족력

부모·형제 등 직계 가족 중 위암 환자가 있는 경우입니다. 건강보험이 적용됩니다.

### 권함 · 위축성 위염·장상피화생

위암 전 단계 변화입니다. 진행 위험을 낮추려고 권합니다.

### 권함 · 그 밖의 경우

원인 모를 혈소판 감소(특발성 혈소판감소성 자반증)·철결핍 빈혈, 본인이 원하는 경우 등.

Tip · 해당하는지 헛갈리면 진료 때 결과지를 함께 보며 정합니다.

근거 · 대한헬리코박터·상부위장관연구학회 진료지침 2022 · 건강보험 적용 기준

## 처음 치료할 때 쓰는 약 조합

국내 지침은 내성검사에 맞춘 치료를 우선하며, 경험적 치료로 10일 동시요법 등을 권합니다

| 조합                 | 들어가는 약 · 먹는 횟수                                                                              | 기간                |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 표준 삼제요법<br>내성 확인 후 | 위산억제제(PPI) 표준용량 · 아목시실린 1000mg · 클라리스로마이신 500mg — 모두 <b>하루 2번</b>                           | 14일               |
| 비스무트 사제요법          | 위산억제제 표준용량 <b>하루 2번</b> · 비스무트 300mg·테트라사이클린 500mg <b>하루 4번</b> · 메트로니다졸 500mg <b>하루 3번</b> | 처방에 따라 10일 또는 14일 |
| 동시요법<br>비스무트 없음    | 위산억제제 표준용량 · 아목시실린 1000mg · 클라리스로마이신 500mg · 메트로니다졸 500mg — 모두 <b>하루 2번</b>                 | 10일               |

**왜 조합이 다를까요** 최근 국내 조사(2021~2023년)에서 클라리스로마이신 내성률은 약 33%였습니다. 내성검사 결과에 따라 약을 고릅니다.

Tip · 어떤 조합이든 처방받은 횟수와 기간을 그대로 지키는 것이 가장 중요합니다.

근거 · 대한상부위장관·헬리코박터학회 진료지침 2025

# 1차 치료가 실패해도 다음 단계가 있습니다

1차 성공률은 약 70~85% — 단계를 거치면 대부분 제균됩니다

## 2차 · 비스무트 사제요법

1차에서 쓰지 않았다면 먼저 씹니다. 위산억제제 하루 2번, 비스무트·테트라사이클린 하루 4번, 메트로니다졸 하루 3번.

## 2차 · 레보플록사신 삼제요법

위산억제제·아목시실린 1000mg 하루 2번, 레보플록사신 500mg 하루 1번을 14일 먹습니다.

## 3차 · 맞춤 치료

균 배양으로 잘 듣는 항생제를 확인해 고르거나, 리파부틴이 든 조합을 검토합니다.



설명용 그림 · 치료 단계를 거칠수록 균이 줄고, 마지막에 요소호기검사·대변 검사로 제균을 확인합니다.

Tip · 2차 치료 성공률은 약 70~80%, 단계를 모두 거친 누적 성공률은 95% 이상입니다.

근거 · 대한헬리코박터·상부위장관연구학회 진료지침 2022

## 치료 시작부터 제균 확인까지

약을 끝낸 뒤 충분히 기다려야 재검사가 정확합니다



설명용 그림 · 알약과 달력 — 정해진 기간 동안 빠짐없이 먹어야  
균이 없어집니다.

Tip · 재검사 전 위산억제제를 언제 끊을지는 의사 지시에 따릅니다.

### 1 치료 시작 첫날

처방받은 약을 정해진 시간에 먹기 시작합니다. 첫날부터 술을 마시지 않습니다.

### 2 치료 끝 처방 기간

한 알도 빼먹지 않고 끝까지 먹습니다. 가벼운 부작용은 스스로 끊지 말고 연락합니다.

### 3 기다리기 4주 이상

재검사 전 위산억제제는 최소 2주, 항생제는 4주 이상 끊어야 합니다. 그 사이 다른  
항생제를 먹었다면 검사 날짜를 다시 정합니다.

### 4 제균 확인 재검사

요소호기검사나 대변 항원검사로 확인하고, 양성이면 2차 치료를 검토합니다.

근거 · 대한헬리코박터·상부위장관연구학회 진료지침 2022

# 제균의 성패는 약을 빠짐없이 먹는 데 달려있습니다

처방 그대로, 끝까지 드세요

## 정해진 시간에

위산억제제는 식사 30분 전, 항생제는 식사 직후나 식사와 함께 먹습니다.

## 메트로니다졸 복용 시 금주

복용 중과 마지막 복용 뒤 72시간 동안 술을 마시지 마세요. 메스꺼움·구토·얼굴 붉어짐이 생길 수 있습니다.

## 빼먹지 말고 끝까지

덜 먹으면 약이 안 듣는 균이 생깁니다. 좋아져도 끝까지, 빼먹었으면 바로 문의하세요.

## 약을 멈추고 연락 · 숨이 차면 응급실

심한 설사·발진·황달이면 약을 멈추고 연락하세요. 지사제는 스스로 먹지 마세요.



설명용 그림 · 치료 중에는 술을 멀리하고, 발진 같은 이상이 생기면 바로 알립니다.

Tip · 메트로니다졸 복용 중과 마지막 복용 뒤 72시간 동안 금주하세요.

근거 · 미국 국립의학도서관 메트로니다졸 복약정보(MedlinePlus)

## 흔한 부작용은 대부분 가볍습니다

미리 알아 두면 당황하지 않습니다 — 약을 끝내면 대개 사라집니다

### 대개 가벼움 — 계속 드세요

치료를 마치면 좋아집니다

- 메스꺼움·입맛 없음 — 식사와 함께 먹으면 덜합니다
- 설사·배 불편감 — 항생제 때문이며 보통 가볍습니다
- 쓴맛·쇠 맛(약을 끊으면 회복), 두통·어지러움(머칠 안에 좋아짐)
- 검은 변 — 비스무트 때문에 흔함(출혈 변화는 구분 필요)

VS

### 약을 멈추고 바로 병원에 연락

약을 바꾸거나 멈춰야 할 수 있습니다

- 물설사가 하루 6번 이상
- 몸 전체에 퍼지는 발진·가려움(약 알레르기 가능)
- 눈이나 피부가 노래짐(황달)
- 두통·어지러움이 심해 일상이 어려움

**이럴 땐 응급실로** 짜장처럼 검고 끈적한 변이나 그와 함께 어지러움이 있을 때(출혈 가능성), 약을 먹은 뒤 숨이 차거나 얼굴·입술이 부을 때.

Tip · 경미한 부작용은 약 20~30%에서 생기고, 이 때문에 치료를 멈추는 경우는 5% 미만입니다.

근거 · 대한헬리코박터·상부위장관연구학회 진료지침 2022

## 치료 기간 동안 지킬 일곱 가지

단순하지만 제균 성공을 가르는 규칙입니다

**01** 처방받은 약을 정해진 시간에 정확히 먹기

**02** 메트로니다졸 복용 중·마지막 복용 뒤 72시간 금주

**03** 증상이 좋아져도 마음대로 끊지 않기

**04** 한 번 빼먹었다면 바로 병원에 문의

**05** 치료가 끝나고 4주 이상 지나 재검사 예약

**06** 재검사 전 위산억제제 2주 끊기(의사 지시대로)

**07** 가족도 검사·치료를 함께 상의하기

Tip · 한 번에 끝내는 것이 가장 쉽고 효율적입니다.

근거 · 대한헬리코박터·상부위장관연구학회 진료지침 2022

## 다시 보기 · 문의

QR로 다시 보기 · 복약 점검표는 [한 장 안내문](#)에서 확인하세요

### **광교바른내과**

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

### **이 자료의 성격**

헬리코박터 제균 치료를 시작하는 분과 가족을 위한 설명자료입니다. 약 조합과 기간은 담당 의사가 정합니다.

### **참고한 자료**

대한상부위장관·헬리코박터학회 진료지침 2025 · 국제암연구소(IARC) 발암물질 분류 · 건강보험 적용 기준



SCAN TO REVISIT

**집에서 다시 보기**

QR을 스캔하면 핸드폰에서  
같은 자료를 다시 볼 수 있어요